

EXAMEN DE RESIDENCIAS MEDICAS

CÓRDOBA – 2020

- 1) ¿Cuál es la manifestación más frecuente en los pacientes con litiasis biliar?
- a) **Cólico biliar.**
 - b) Síndrome coledociano.
 - c) Cáncer de vesícula.
 - d) Fistula colédoco digestivo.
-
- 2) Todas las siguientes lesiones son premalignas excepto:
- a) **Pólipos hiperplásicos aislados.**
 - b) Adenoma vellosa.
 - c) Poliposis familiar.
 - d) Pseudopolipos en colitis ulcerosa.
-
- 3) Las infecciones quirúrgicas forman parte de las más frecuentes infecciones nosocomiales, provocando un incremento notable de la morbilidad y de los costos asistenciales y sociales de los pacientes. Hay algunas medidas que consiguen reducir estas infecciones. Indique cual es la mas eficaz:
- a) Nutrir al enfermo adecuadamente, ingresándolo para un mejor control en el hospital tres días antes de la intervención.
 - b) Darle antibióticos profilácticos de bajo costo antes de todo tipo de intervención.
 - c) Evitar las transfusiones.
 - d) **Reducir todo lo posible la estancia preoperatoria del enfermo, ingresándolo el mismo día de la intervención o como máximo la tarde anterior.**
-
- 4) La colecistectomía por cirugía videolaparoscópica está contraindicada en:
- a) Colecistitis aguda.
 - b) Síndrome coledociano.
 - c) Insuficiencia renal.
 - d) **Sospecha de cáncer de vesícula.**
-
- 5) Los criterios tomográficos de Balthazar ¿En qué patología se aplican?
- a) Tumor de páncreas.
 - b) **Pancreatitis aguda.**
 - c) Pancreatitis crónica.
 - d) Tumor de vía biliar distal.
-

- 6) ¿Cuál de los siguientes cuadros de abdomen agudo pueden tener resolución con tratamiento médico?
- a) Perforación de ulcera gástrica.
 - b) Perforación de apéndice.
 - c) **Pancreatitis.**
 - d) Embarazo ectópico.
-

- 7) ¿Cuál es el tipo histológico más común en el cancer gástrico?
- a) Linfoma.
 - b) **Adenocarcinoma.**
 - c) Leiomioma.
 - d) Carcinoides.
-

- 8) Mujer de 70 años, que consulta por cuadro de poco tiempo de evolución, con intensa astenia, dolor abdominal y vómitos a repetición. Muestra una intensa pigmentación melánica cutáneo mucosa y esta con hipotensión arterial. Se comprueba hiponatremia intensa, con hiperpotasemia e hipoglucemia. Con estos datos, la sospecha diagnóstica ser:
- a) Insulinoma.
 - b) **Insuficiencia suprarrenal primaria crónica.**
 - c) Coma mixedematoso.
 - d) Crisis tirotoxicas.
-

- 9) ¿Cuál es la manifestación clínica más frecuente de los tumores renales?
- a) Dolor lumbar.
 - b) **Hematuria.**
 - c) Hipercalcemia.
 - d) Hipertensión arterial.
-

- 10) La anemia perniciosa presenta como característica:
- a) Eritrocitos microcíticos e hipocrómicos.
 - b) **Anticuerpos contra el factor intrínseco de Castle**
 - c) Hipertrófica de la mucosa gástrica.
 - d) Ausencia de predisposición genética.
-

- 11) ¿Cuál es el tumor que frecuentemente se asocia a miastenia gravis?
- a) Cáncer de mama.
 - b) Cáncer de colon.
 - c) **Timoma.**
 - d) Cáncer de pulmón.
-

12) Para el diagnóstico de artritis gotosa es necesario la identificación de depósitos de cristales intraarticulares. Marque la opción CORRECTA respecto a su composición:

- a) **Cristales de urato monosódico.**
 - b) Cristales de pirofosfato de calcio.
 - c) Cristales de hidroxapatita.
 - d) Cristales de oxalato de calcio.
-

13) La causa más frecuente de una marcha hemiparética en las personas mayores de 60 años es:

- a) Contusión cerebral.
 - b) Tumor cerebral.
 - c) **Accidente cerebrovascular.**
 - d) Absceso cerebral.
-

14) ¿Cuál es la cefalea primaria más frecuente?

- a) Cefalea en racimos.
 - b) Cefalea de esfuerzo.
 - c) **Cefalea tensional.**
 - d) Cefalea ortostática.
-

15) En el contexto de la migraña, el aura más típica se manifiesta en forma de:

- a) Parestesia.
 - b) Diplopía.
 - c) **Fotopsias.**
 - d)
-

16)

- a)
 - b) **Helicobacter pylori y antiinflamatorios no esteroideos.**
 - c) Nefrolitiasis e Insuficiencia Renal Crónica.
 - d) Hiperparatiroidismo primario y mastocitosis generalizada.
-

17) El trastorno de conducción más frecuente en la Enfermedad de Chagas es:

- a) Bloqueo completo de rama izquierda.
 - b) Hemibloqueo posterior izquierdo.
 - c) **Bloqueo completo de rama derecha.**
 - d) Bloqueo A – V de primer grado.
-

18) Señale cual de las siguientes recomendaciones profesionales promueve la lactancia materna.

- a) **Contacto precoz piel a piel con el recién nacido y lactancia a demanda espontánea.**
 - b) Lactancia por 10 minutos de cada pecho cada 3 o 4 horas.
 - c) Complementar con biberones por la noche para mejorar el descanso de la madre.
 - d) Extracción de leche para evitar la ingurgitación mamaria y administrársela con biberón.
-

19) Hasta que edad recomienda lactancia materna exclusiva la Organización Mundial de la Salud.

- a) Hasta los 2 meses.
 - b) Hasta los 4 meses.
 - c) **Hasta los 6 meses.**
 - d) Hasta los 12 meses.
-

20) Según el CALENDARIO vigente en Argentina, la vacuna triple viral se administra:

- a) Solo a los 12 meses.
 - b) A los 18 meses y a los 15 años.
 - c) **A los 12 meses y a los 6 años.**
 - d) Depende del posible riesgo de epidemia de varicela.
-

21) Niño de 2 meses que acude a urgencias por tos emetizante, con antecedentes de congestión de vías aéreas superiores y episodios de apnea con cianosis. No a presentado fiebre. ¿Cuál es el agente etiológico más probable de este cuadro?

- a) Virus Respiratorio Sincitial.
 - b) Influenza.
 - c) Rinovirus.
 - d) **Bordetella pertussis.**
-

22) Niño de 7 meses de edad, con deshidratación debido a vómitos y diarrea, presenta los siguientes resultados de laboratorio. Sodio 137mEq/L; Potasio 5,6 mEq/L; pH 7,20; pCO₂ 25 mmHg; CO₃H 11 mEq/L; EB – 19 mEq/L; Lactato 5,3 mEq/L; ¿Cuál es la valoración metabólica de la deshidratación que presenta este paciente?

- a) Deshidratación isotónica con acidosis mixta.
 - b) Deshidratación hipotónica con acidosis metabólica.
 - c) **Deshidratación isotónica con acidosis metabólica.**
 - d) Deshidratación hipertónica con acidosis metabólica.
-

23) Con respecto a las convulsiones febriles típicas:

- a) Puede ocasionar secuelas.
- b) **Se presentan entre los 6 meses y los 6 años.**
- c) Debe medicarse con fenobarbital hasta los 6 años.
- d) Ocurren una sola vez en la vida.

24) Juan es un niño de 2 años que es traído a consulta por presentar de forma brusca: dolor de garganta, salivación, mal aliento y fiebre de 39 °C.

- a)
- b)
- c)
- d)



25)

- a)
- b) Gastroenteritis infecciosa.
- c) Enfermedad celiaca.
- d) Parasitosis intestinal.

26) Señale de los siguientes cual es un hito anormal durante el primer año de vida.

- a) Desaparición del reflejo de moro luego del primer mes de vida.
- b) Sostén cefálico completo al sexto mes de vida.
- c) Reflejo tónico del cuello (postura de espadachín) persistente hasta el séptimo mes.
- d) Reflejo de búsqueda en el primer trimestre.

27) Paciente de 4 años de edad que consulta por diarrea aguda, amaurosis aguda e hipertensión arterial, se objetivan lesiones impetiginizadas en piel, su sospecha diagnóstica es:

- a) Migraña compleja.
- b) Glomerulonefritis.
- c) Tumor cerebral.
- d) Endocarditis bacteriana.

28) El cuadro clínico caracterizado por fiebre, aftas orales y vesículas en manos y pies, es producido por el siguiente agente etiológico:

- a) Parvovirus B 19.
- b) Virus Herpes Simple.
- c) Virus Herpes Humano 6 y 7.
- d) Enterovirus no polio.

29) En un traumatismo abdominal cerrado de abdomen en un niño, el órgano que mas frecuentemente puede lesionarse es:

- a) El hígado.
- b) El bazo.
- c) El duodeno.
- d) El páncreas.

30) Señale cuál de las siguientes vacunar requiere, antes de su aplicación, conocer el grado de inmunosupresión en pacientes con infección por HIV.

- a) Vacuna Triple Bacteriana.
- b) Vacuna Antipolio (IPV).
- c) Vacuna Anti-Hepatitis B.
- d) **Vacuna Triple Viral.**

31) Niño de 6 años que comienza hace 24 hs con fiebre, dolor de garganta y vómitos. Hoy presenta exantemas en cara y tronco, micropapular rojo, rugoso al tacto con lengua saburral, sin adenomegalia, usted piensa en:

- a) Sarampión.
- b) Rubeola.
- c) **Escarlatina.**
- d) Mononucleosis Infecciosa.

32) ¿En qué consiste el Plan A para tratar un lactante con diarrea sin deshidratación, en la terapia de rehidratación oral (TRO)?

- a) Administrar Sales de Rehidratación Oral (SRO) en un plan de 4 a 5 horas.
- b) **Continuar con la alimentación habitual, dar mas liquido que lo habitual, ofrecer SRO después de cada deposición diarreica y reconocer signos de alarma.**
- c) Continuar con la alimentación habitual y concurrir a control a las 48 hs.
- d) Internación urgente del paciente con rehidratación parenteral exclusiva.

33) ¿La aparición de Kernicterus del Recién Nacido se asocia con cual de estas patologías?

- a) Infección connatal.
- b) Rotura prematura y precoz de membranas.
- c) **Hiperbilirrubinemia por incompatibilidad sanguínea materno-fetal.**
- d) Diabetes gestacional.

34) La localización mas frecuente del embarazo ectópico es:

- a) Porción ístmica de la trompa.
 - b) Porción intersticial de la trompa.
 - c) **Porción ampular de la trompa.**
 - d) Porción intramural.
-

35) ¿Cuál de las siguientes malformaciones congénitas se asocia con el déficit de ácido fólico?

- a) Malformaciones retinianas.
 - b) Acondroplasia.
 - c) Defectos del tubo neural.
 - d) Cretinismo.
-

36) De todas las masas anexiales malignas diagnosticadas en el embarazo, la mas frecuente es:

- a) Disgerminoma.
 - b) Cistoadenocarcinoma seroso.
 - c) Cistoadenocarcinoma mucinoso.
 - d) Tumor de células granulosas.
-

37) La medicación local mas efectiva indicada ante el prurito vulvar por liquen escleroso es:

- a) Estrógenos.
 - b) Progesterona.
 - c) Estrógenos conjugados equinos.
 - d) Corticoides locales.
-

38) Paciente de 35 años cursando embarazo de 32 semanas de gestación, consulta a la guardia con genitorragia, al examen físico se constata: TA 180/120, hipertoniá uterina, latidos cardiofetales 100x'. Cual seria la conducta correcta:

- a) Estabilización de la TA y monitoreo fetal.
 - b) Solicita laboratorio con perfil de preeclampsia y ecografía Doppler.
 - c) Cesárea de urgencia
 - d) Internación en UTI para completar maduración pulmonar con estricto control de TA.
-

39) Paciente de 25 años, gestas 1, paras 1. Refiere dolor abdominal de comienzo brusco de 3 hs de evolución, fiebre de 38 °C, leucorrea escasa con olor fétido verdoso. ¿Qué diagnostico sospecha?

- a) Enfermedad Pélvica Inflamatoria.
 - b) Embarazo Ectópico.
 - c) Quiste hemorrágico.
 - d) Infección Urinaria.
-

40) Se presenta a la consulta paciente de 26 años con deseo de fertilidad, que manifiesta amenorrea y galactorrea bilateral. ¿Qué sospecha?

- a) Esterilidad por Síndrome de Ovario Poliquístico.
 - b) Hiperprolactinemia.
 - c) Hiperinsulinemia.
-

41)

- a)
 - b)
 - c) Infección.
 - d) Hiperuremia.
-

42) ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al termino metrorragia?

- a) Hemorragia proveniente del útero sin relación con el ciclo.
 - b) Hemorragia proveniente de cualquier lugar del tracto genital sin relación con el ciclo.
 - c) Hemorragia en relación con el ciclo.
 - d) Perdida sanguínea postcoital.
-

43) ¿Cuál de los siguientes patrones hormonales de las postmenopáusicas es más probable en una mujer de 65 años?

- a) Gonadotrofinas disminuidas, y estrógenos y progesterona disminuidas.
 - b) Gonadotrofinas disminuidas, y progesterona elevada.
 - c) Gonadotrofinas elevadas, y hormonas ováricas disminuidas.
 - d) Gonadotrofinas elevadas, estrógenos y progesterona elevadas.
-

44) Paciente de 70 años de edad con tumor palpable en cuadrante superoexterno de mama derecha, asociado en la mamografía a imagen de bordes espiculados y microcalcificaciones. Usted debe pensar en:

- a) Fibroadenoma de mama.
 - b) Enfermedad de Paget.
 - c) Displasia mamaria severa.
 - d) Cáncer de mama.
-

45) Se entiende por consentimiento informado, la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto a:

- a) Su estado de salud.
 - b) Su estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos.
 - c) Su estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos; los beneficios esperados del procedimiento; los riesgos, molestias y efectos previsibles.
 - d) Su estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos; los beneficios esperados del procedimiento; los riesgos, molestias y efectos previsibles; la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos y las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados.
-

- 46) Uno de los derechos del paciente es la “Autonomía de la Voluntad”, esto le permite al paciente:
- a) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa.
 - b) Solicitar al profesional de la salud la destrucción total de la historia clínica la cual el paciente es el titular.
 - c) En caso de extrema gravedad y situación de emergencia del paciente, imponerle al medico que interviene un tratamiento determinado sobre su cuerpo.
 - d) Solicitarle al medico medicamentos que no corresponden con ningún diagnostico determinado realizado en el paciente.
-

- 47) ¿Cuándo el profesional de la salud puede actuar sin el consentimiento informado del paciente?
- a) Cuando mediar grave peligro para la salud pública.
 - b) Cuando mediar una situación de emergencia, con grave peligro para la salud incluso cuando el paciente pueda presentar su consentimiento por si mismo.
 - c) Cuando mediar una situación de emergencia, con grave peligro para la salud incluso cuando el paciente no pueda presentar su consentimiento, pero si puede hacerlo un pariente.
 - d) Cuando el paciente se encuentre con la posibilidad de poder rechazar tratamiento indicados.
-

- 48) Como profesionales de la salud, si el paciente le solicita la historia clínica, Ud. debe:
- a) Entregar copia de la misma, sin autenticar por autoridad competente de la institución asistencial.
 - b) Entregar copia de la misma, autenticada por autoridad competente de la institución asistencial.
 - c) Entregar copia de la misma, autenticada por autoridad competente de la institución asistencial. La entrega se realizará dentro de las 48 horas de solicitada, salvo casos de emergencia.
 - d)
-

- 49) ¿Cuál es el cáncer de páncreas más frecuente?: Adenocarcinoma ductal.
-

- 50) Paciente con abdomen agudo hemorrágico con shock, que es lo primero que haces: tratar la inestabilidad.
-

- 51) Te daba la clínica de un viejo con síndrome pilórico, en que dx piensas: Ca gástrico.
-

- 52) Que tumor causa síndrome obstructivo: Ca de colon descendente.
-

- 53) Tumor renal más frecuente:
- a) Tumor de células claras
 - b) Adenocarcinoma
 - c) Incidentaloma
-

54) ¿Cuál es la clínica del Ca de esófago? Disfagia

55) Paciente con VDRL + en el embarazo:

- a) Realizar tratamiento.
 - b) Realizar FTAbs para confirmar.
-

56) Clínica de Úlcera péptica: dolor epigástrico

57) Úlcera en estómago, bulbo y 2da porción del duodeno + esteatorrea: Gastrinoma

58) Síntoma atípico de ERGE: laringitis

59) Complicación 100% de tiroidectomías: hipotiroidismo

60) Sangrado en recto:

- a) Ca de recto
 - b) Hemorroides
 - c) Fístula
 - d) A y B son correctas
-

61) Factores de riesgo para úlcera: Helicobacter pilory + AINEs

62) ¿Cuál es la causa más frecuente de Insuficiencia Suprarrenal Primaria?: suprarrenalitis autoinmune (no es TBC, la opción es causa AUTOINMUNE)

63) ¿Como haces diagnóstico de una perforación de víscera hueca?

- a) Rx de Tórax
 - b) Rx de Abdomen
-

64) Signo de Jobert: neumoperitoneo

65) Principal causa de muerte en ca cuello:

- a) Hemorragia
 - b) Hiperuricemia
 - c) Infección
-

66) Diagnóstico de colelitiasis: ECO

67) Principal causa shock en pediatría: Shock Hipovolémico

68) Difteria

69) Paciente vacunado con la Vacuna de HB, que encontras en sangre: Anticuerpo anti HBags

70) Caso de un nene con clínica de Púrpura SH

71) Niño con fiebre, estado tóxico y púrpura, Dx: meningococemia

72) Principal causa de derrame exudativo: Neumonía

73) Cuerpo extraño en vías aéreas superiores, clínica: ahogo, sofocamiento, tos.

74) Artrosis primaria

75) Causas de DPPNI: preeclampsia

76) Cuál es el musculo del cual deriva el Cremáster: oblicuo menor (algo así, vofi)

77) Origen arteria ovárica: aorta

78) Candidiasis esofágica: marcadora de sida

79) Niño mayor a 6 meses con vómitos: reflujo / sobrealimentación (averiguar)

80) Niño con ttraumatismo y convulsiones: interno y tac

81) Principal causa de marcha hemiparetica en > 60: ACV

82) Complicación de resfrío común: otitis

83) Debilidad en miembros inferior que cede con el descanso, leve ptosis palpebral: Miastenia Gravis

84) Cual no es complicación de Enfermedad de Crohn: poliposis

85) Infección puerperal más frecuente: endometritis (no mastitis)

86) Triada de Charcot: ictericia, dolor en hipocondrio derecho y fiebre

87) Enfermedad Hemolítica: madre Rh -, padre Rh +, Coombs indirecta negativa

88) Como realizo diagnóstico de presencia de estrógenos: prueba de progesterona

89) Dengue

90) Síndrome nefrotico primario en pediatría: enfermedad de cambios mínimos

91) Screening de mama: mamografía

92) Mujer embarazada de 9 meses le diagnostican Listeriosis. Cuál es la vía de contagio de más frecuente de la madre: vía digestiva CORRECTA (otras opciones: vía transplacentaria, canal de parto, transfusiones) (PREGUNTA SOBRE LA VIA DE CONTAGIO DE LA MADRE NO DEL HIJO)

93) Criterio mayor de IC (criterios de Framingham): reflujo hepatoyugular

94) Hemorragia en la posmenopausia: histeroscopia + biopsia

95) Mamo y palpación anual a partir de los 40: screeing de cáncer de mama

96) Nena de 11 meses que desde los 8 presenta esteatorrea, hipoalbuminemia, anemia. A los 6 había incorporado harinas: enfermedad celiaca

97) Causa de alcalosis metabólica: Diurético de asa

98) Empiezan a caminar: de 12 a 15
